

2022/2

**COMPILADO DE TODAS AS QUESTÕES DE PROVAS E TESTES ANTIGOS QUE
ENCONTREI COM BÔNUS DE TÓPICOS MAIS IMPORTANTES A SEREM
ESTUDADOS PARA PROVA FINAL NA ÚLTIMA PÁGINA DO DOCUMENTO**

QUESTÕES P1

1 - 4 diferenças de gênero no crânio.

Arco superciliar mais proeminente no crânio masculino

Túber frontal mais proeminente

Processo mastóide mais desenvolvido em homens

Ângulo da mandíbula é mais agudo em homens

2 - a) Relações anatômicas não ósseas da parte orbital do osso frontal.

Relaciona-se superiormente com o lobo frontal do cérebro e ínfero-lateralmente com a glândula lacrimal

b) A importância de saber disso.

Se houver um impacto na direção da escama do osso frontal, poderá haver um escorrimento do líquido encefalorraquidiano da fossa anterior do crânio para a cavidade da órbita.

3 - Identificar. O que passa e relações anatômicas.

Sulco basilar - Está no osso occipital numa vista endocraniana e passa artéria basilar. Relaciona-se posteriormente com o forame magno. Lateralmente com o canal do n. hipoglosso. Abriga ponte e bulbo do tronco encefálico.

Canal do n. hipoglosso - Relaciona-se superior e lateralmente com o forame jugular. Passa o n. hipoglosso e veias emissárias do canal hipoglosso.

Forame jugular - Passa veia jugular, n. glossofaríngeo, n. vago e n. acessório. Relaciona-se inferior e medialmente com o canal do n. hipoglosso. Relaciona-se medialmente com o forame magno.

4 - Conteúdo não muscular do trígono submandibular (ele deu nota total só pra quem colocou de 9 a 11 conteúdos).

Glândula submandibular, linfonodos submandibulares, a. facial, v. facial, n. milo-hióideo, linfonodos cervicais laterais profundos, v. jugular interna, ápice da gl. parótida, n. glossofaríngeo, n. vago, n. hipoglosso, a. carótida interna e externa

5 - Identificar a a. tireóidea inferior. Anastomoses e o que irriga.

Anastomoses: a. tireóidea inferior contralateral, com a. tireóidea superior (ACE + Subclávia) Irriga laringe, cartilagem e gl. tireoide

6 - Acidentes ósseos que se relacionam com o forame jugular.

Sulco do seio petroso inferior, sulco do seio sigmóide, canal do n. hipoglosso, meato acústico interno

7 - Descrever a formação das paredes do seio maxilar e com que se relacionam.

Anterolateral - relaciona-se anterolateralmente com a face

Medial - relaciona-se medialmente com a parede lateral da cavidade nasal

Posterior - relaciona-se posteriormente com a fossa infratemporal e a parte mais medial se relaciona com a fossa pterigopalatina

Superior - relaciona-se superiormente com a órbita

Inferior - relaciona-se inferiormente com o palato e raízes dos dentes superiores posteriores

8 - Identificar e dar o trajeto e relações anatômicas da veia jugular interna do seu início ao seu término.

O seio petroso inferior e o seio sigmóide drenam em direção ao forame jugular na base do crânio, o sangue venoso que fora coletado na cavidade craniana. Ele passa em direção superior para inferior no forame jugular na bainha carótica, lateralmente ao n. vago e à a. carótida interna, passando profundamente ao m. esternocleidomastoideo e termina posteriormente à clavícula, se juntando à veia subclávia, que formará a veia braquiocefálica

9 - Identificar (corte coronal, crânio infantil) m. milo-hióide e v.a. do m. digástrico. Origem, inserção e ação.

M. milo-hióide: origem: linha milo-hióidea na margem medial do corpo da mandíbula

Inserção: fibras anteriores se prendem na rafe milo-hióidea e suas fibras posteriores se inserem no corpo do osso hióide. Ação: eleva o assoalho da boca e a língua

Ventre anterior do m. digástrico: origem VA: fossa digástrica; origem VP: incisura mastoidea no processo mastóide do osso temporal. Inserção: tendão intermediário do m. digástrico, presa no corpo e corno maior do osso hióide. Ação VP: eleva o osso hióide e retrai; Ação VA: eleva e protraí o osso hióide

10 - Marcava alguns acidentes ósseos da mandíbula (linha milo-hióidea, língua e outras) e pedia relações anatômicas entre eles.

Língua: Localizada na face medial do ramo da mandíbula, onde se insere o ligamento esfenomandibular.

Linha milo-hióidea: localizada na face medial do corpo da mandíbula, onde se insere o m. milo-hióideo.

língua - lateral e superior a linha, que está medial.

11 - Alfinetes marcando a lâmina superficial da fáscia cervical e a lâmina muscular da lâmina pré-traqueal da fáscia cervical. A infecção vai para o mediastino. Certo ou errado? Justifique.

Errado, porque a lâmina muscular da lâmina pré traqueal da fáscia cervical não é contínua com mediastino, se fixa superiormente no osso hióide e inferiormente no esterno.

12 - Identificar os acidentes e dar as comunicações:

- a) Forame palatino maior - fossa ptpl com cavidade oral;
- b) Fissura pterigomaxilar - fossa ptpl com fossa infratemporal;
- c) Forame infraorbital - órbita com face.

13 - Identificar a v. jugular interna e externa e linfonodos que acompanham.

v. jugular interna - linfonodos cervicais laterais profundos

v. jugular externa - linfonodos cervicais laterais superficiais

14 - Identificar as estruturas e o que passa nelas:

Hâmulo pterigóideo - tendão do m. tensor do véu palatino;

Crista infratemporal - cabeça superior do m. pterigóideo lateral;

Sela turca - glândula hipófise;

Sulco carótico - a. carótida interna;

Forame redondo - n. maxilar

15 - Identificar as artérias e dizer qual delas tem íntima relação com:

a) colo da mandíbula; - parte mandibular da a. maxilar

b) m. hiogloso; - a. lingual

c) n. hipoglosso. - a. facial (origem dela)

16 - Identificar as partes do osso etmóide e dizer quais cavidades ele contribui para formação.

seio etmoidal - células etmoidais

lâmina cribiforme - cavidade nasal e fossa anterior do crânio

17 - Identificar a a. facial. Falava que foi rompida e que precisaria de uma intervenção na sua origem.

a) Quais camadas precisaria atravessar para intervir no vaso?

pele-tela subcutânea- ventre posterior do m. digástrico

b) Em qual trígono se encontra sua origem?

trígono submandibular

18 - a) Quais são os pontos craniométricos utilizados para medir a altura da face? E a largura?

Altura - násio e gnacio

Largura: bizígio (dois pontos malares)

b) Qual a importância disso?

Determinar o tipo facial do indivíduo em relação às suas dimensões, como em leptoprósopos (face mais alta do que larga) e euriprósopos (face mais larga do que alta).

19 - O que influencia no crescimento da maxila?

Ação dos mm. da mastigação, crescimento laterolateral pela sutura palatina mediana, crescimento anteroposterior pela sincondrose esfeno occipital.

20 - Cite os seios venosos da dura-máter que desembocam no forame jugular.

Seio petroso inferior e seio sigmóide

21- Marcava a língua e pediu estruturas neurovasculares que se relacionavam com ela e o principal ligamento que se inseria. Pedia tbm relação anatômica não óssea posterior

Nervos e vasos alveolares inferiores e ligamento esfenomandibular.

22- marcava a fossa pterigopalatina e pedia principal artéria e nervo que ali passavam e onde a artéria terminava

Parte pterigopalatina da artéria maxilar

Nervo maxilar (forame redondo)

23- marcava a incisura da mandíbula e perguntava relação anatômica não óssea anterior e posterior e como se faz para manipular a incisura in vivo**

Posterior: músculo pterigóideo lateral se inserindo na fóvea pterigóidea

Anterior: músculo temporal se inserindo no processo coronóide

24- marcava a fossa média do crânio e pedia limite não ósseo anterior e posterior

Limite anterior: seio esfenoparietal

Limite posterior: seio petroso superior

25- teórica: pedia o trajeto dos principais linfonodos

26- ramos da artéria maxilar

A. Alveolar inferior, a. Meníngea média

A. Massetérica, a. Bucal, a. Temporal profunda anterior e média

A. Esfenopalatina, a. Infraorbital, a. Palatina descendente, a. Alveolar superior posterior anterior e média, a. Do canal pterigóideo

A. Meníngea média, a. Alveolar inferior, a. Bucal, a. Massetérica, aa. Alveolares superiores, a. Temporal profunda anterior e posterior, a. Esfenopalatina, a. Do canal pterigóideo, a. Infraorbital

27- trajeto da carótida interna

28- elemento 36, infecção ia pra qual trígono e quais estruturas podiam ser lesadas.

Trígono submandibular, glândula submandibular, a. facial, linfonodos submandibulares

29- elemento 37. Qual trajeto um grão de arroz faria para chegar na cavidade nasal e na região dos incisivos centrais superiores

30- Qual o trajeto completo da artéria maxilar?

31- Marcava o processo mastóide e pedia importância em saber a estrutura.
O processo mastóide protege o nervo facial. Lembra do forame estilomastoideo
Como a criança não tem, o nervo fica suscetível a trauma.

32 - relacione os 4 fontículos com seus respectivos pontos craniométricos

33 - diferenças da mandíbula no adulto e na criança

34 - diferenças das maxilas dentada e desdentada

35 - qual a importância do esfenoide na odontologia

36 - mostrava o osso temporal e pedia a importância na irrigação e drenagem do snc

37 - apontava no sulco basilar, na fossa craniana e na parte superior a fossa craniana, daí pedia quais estruturas se alojam em cada uma delas

38 - pq a sínfise da mandíbula é considerada uma pseudo sínfise

39 - 3 acidentes anatômicos do etmoide que se relacionavam com as funções da cavidade nasal

40 - apontava na fóvea troclear e perguntava pq era uma estrutura difícil de ser localizada

41 - pedia sinais e sintomas do afundamento do zigomático e relação anatômica medial

42 - quais os 2 espaços que o osso zigomático separa

43 - quais estruturas não musculares formam os acidentes anatômicos no corpo da mandíbula

44 - apontava para a face anterior da parte petrosa e perguntava a face e duas estruturas localizadas nela que tinham relação com o ouvido médio interno e externo.

45 - apontava pro tuber parietal:

A) essa estrutura é importante em qual fase da nossa vida

B) cite 2 importâncias dessa estrutura

46 - a) Delimite o triângulo submandibular.

b) Quais dentes poderão disseminar processos infecciosos?

47 - Pq o espaço retrofaríngeo é conhecido como espaço de risco?

48 - Perguntava quais pontos craniométricos eram usados para medir:

a) A altura da face.

b) A largura do crânio.

49 - Apontava na linha temporal superior e perguntava o que poderia causar a alteração dessa estrutura.

50 - a) Apontava no forame infra-orbital e pedia uma relação anatômica interna.

b) Pedia relação anatômica inferior.

51 - Apontava no canal carótico e pedia:

a) O que se passa ali?

b) 3 relações anatômicas posteriores (nervosas).

52 - a) Qual a importância das veias emissárias?

b) 2 acidentes anatômicos em que elas passam.

53 - Sobre a lâmina óssea apontada (lâmina perpendicular do osso palatino), responda:

Qual a sua relação com a fossa pterigopalatina? (era pra falar que era a parede medial da fossa)

54 - Apontava no occipital, processos condilares e outro osso e perguntava com qual osso cada um se articula.

55 - Cite o nome de 5 acidentes ósseos que se abrem na fossa pterigopalatina.

56 - Apontava no canal pterigóideo:

a) Qual o conteúdo?

b) Utilize 4 termos de posição para localizar a estrutura apontada.

57 - O que se prende na linha temporal e importância de saber do supercílio

58 - hâmulos pterigóideos: 2 músculos que se prendem e função de um desses

59 - função do fontículo anterior e tuber parietal

60 - importância dos pontos craniométricos para odontologia

61 - traumas que podem afetar o osso frontal

- 62 - relação anterior e medial do forame jugular e os nervos que passam
- 63 - processo estilóide o que se prende e sinais e sintomas de seu alongamento
- 64 - osso hióide função e sinais e sintomas de fratura
- 65 - Estruturas que drenam para os linfonodos pré auriculares/ submentuais.
- 66 - quais regiões o esfenóide delimita
- 67 - Identificar a a. meníngea média e dizer em que ponto ela pode sofrer trauma e a consequência desse trauma
- 68 - v. Retromandibular (duas relações anatômicas e duas regiões que ela drena)
- 69 - importância nervo auricular magno e onde é encontrado
- 70 - 3 anastomoses da carótida interna
- 71 - processo mastóide menos desenvolvido na criança e oq isso acarreta (nervo facial exposto/ risco de rompimento)
- 72 - importância clínica do espaço submandibular
- 73 - importância clínica e limites do espaço retrofaríngeo
- 74 - importância do osso parietal na face interna
- 75 - vasos ou nervos que passavam em três estruturas: forame infraorbital/ forame no osso nasal/ processo frontal da maxila
- 76 - a) Delimite o triângulo submandibular.
b) Quais dentes poderão disseminar processos infecciosos?
- 77 - Pq o espaço retrofaríngeo é conhecido como espaço de risco?
- 78 - a) Apontava no forame infra-orbital e pedia uma relação anatômica interna.
b) Pedia relação anatômica inferior.
- 79 - Sobre a lâmina óssea apontada (lâmina perpendicular do osso palatino), responda:
Qual a sua relação com a fossa pterigopalatina? (era pra falar que era a parede medial da fossa)

80 - Apontava no occipital, processos condilares e outro osso e perguntava com qual osso cada um se articulava.

81 - Cite o nome de 5 acidentes ósseos que se abrem na fossa pterigopalatina.

82 - Apontava no canal pterigóideo:

a) Qual o conteúdo?

b) Utilize 4 termos de posição para localizar a estrutura apontada.

83 - Apontava no colo da mandíbula e no forame mentual:

a) Pedia pra falar uma diferença no colo da mandíbula relacionada a indivíduos dentados e desdentados.

b) Pedia para falar uma diferença no forame mentual relacionada a faixa etária.

84 - Perguntava o que a linha milo-hióidea separa (era pra falar das glândulas).

QUESTÕES P2

1 - Estratimeria da faringe até a coluna vertebral

Mucosa, submucosa, fáscia faringobasilar, camada muscular, fáscia bucofaríngea, espaço retrofaríngeo e lâmina pré-vertebral da fáscia cervical e coluna vertebral.

2 - Irrigação e drenagem linfática do terço anterior do palato duro.

Irrigação: Artéria palatina maior

Drenagem linfática: Linfonodos do colar pericervical e linfonodos cervicais laterais profundos (da cadeia jugular)

3 - Relação medial da parte profunda da gl. parótida e importância de saber disso

M. constritor superior da faringe, aumento na gl. parótida pode causar dor na deglutição

4 - a) M.m longitudinais da faringe (todos);

M. estilofaríngeo, m. salpingofaríngeo e m. palatofaríngeo

b) tonsilas presentes na parte nasal da faringe.

Tonsila faríngea

5 - Origem, inserção e ação do m. constritor superior da faringe.

R.: Origem: parte lateral da faringe, linha milo-hióidea, rafe pterigomandibular e hâmulos pterigóideo

Inserção: rafe da faringe e tubérculo faríngeo

Ação: constrição da faringe

6 - a) Marque o masseter e pedia seus sinergistas (ser específico);

R.: M. pterigóideo medial, bilateralmente: realiza protrusão e elevação da mandíbula assim como a parte superficial do m. masseter;

M. Temporal: realiza elevação (fibras anteriores e médias) e retrusão da mandíbula, assim como a parte profunda do masseter.

b) Duas relações anatômicas laterais

R.: parte superficial da gl parótida e ducto parotídeo

7 - Na ATM, defina:

a) Ângulo de Bennett.

R.: Ângulo formado entre as vertentes lateral e medial da vertente fisiológica (posterior) da eminência articular

b) Lado de não trabalho.

ATM contralateral ao lado de trabalho que realiza maior movimento, realizando uma pequena rotação neste lado de não trabalho.

8 - Sobre o vestíbulo da boca:

a) Defina "brida".

Pregas mucosas projetadas no fórnice do vestibulo da boca, posterolaterais ao freio do lábio superior e inferior

b) Irrigação.

aa. labiais sup e inf; a. mentual; a. alveolar inf.; a. incisiva; a. alveolar superior (anterior, média e posterior); a. facial transversa; a.bucal; ramo labial superior da a. infraorbital

9 - Marcava a estratimeria da região temporal.

a) Cor do alfinete e nome da camada que possui fibras colágenas

Tela subcutânea.

b) Cor do alfinete e nome da camada que possibilita movimentação do couro cabeludo

Tecido subaponeurótico frouxo.

c) Cor do alfinete e nome da camada que é área doadora de enxerto - fáscia temporoparietal/aponeurose epicraniana.

Pele, Tela Subcutânea, Aponeurose Epicrânica (Fáscia Temporoparietal) - vasos temporais superficiais, Tec. Subaponeurótico Frouxo, Fáscia Temporal (a. temporal média), M. Temporal (a. temporal profunda anterior), Pericrânio e Osso

10 - M. Bucinador em corte coronal. Explicar o que poderia acontecer com uma infecção dentária relacionando com o músculo e exemplificar para onde iria a infecção.

Caso a infecção seja em molares da maxila, a infecção pode drenar para o vestibulo da boca (caso a raiz do dente esteja abaixo da inserção do músculo) ou para a região extraoral (caso a raiz do dente esteja acima da inserção). Já em molares inferiores, a infecção pode drenar para o vestibulo da boca, caso a raiz do dente esteja acima do músculo ou para a região extra oral, caso a raiz esteja abaixo da inserção do músculo.

11 - Marcava o ligamento lateral da atm.

a) Movimento que impede

Retrusão exagerada.

b) De acordo com sua constituição, outra importância principal dele.

12 - Marcava o seio maxilar.

a) Por qual parede geralmente se faz o acesso?

R.: Parede anterolateral

b) Vasos que podem ser lesados.

R.: Aa. Alv Sup Ant e Média

c) Nome da comunicação com a boca caso haja rompimento

R.: Comunicação Buco Sinusal

13 - Marcava a região sublingual.

a) Como é o trajeto dos vasos

R.: Lateral para medial e posterior para anterior

b) Por que se deve saber disso?

R.: Planejamento da incisão no mesmo sentido dos vasos para preservação das estruturas.

Existe outro motivo?

R.: Sim, presença do ducto da gl. submandibular nesse sentido

14- Marcava a cabeça superior do m. pterigóideo lateral em corte coronal.

a) Ações

R.: abertura da boca e protrusão (agindo bilateralmente). Lateralidade quando age de forma unilateral

b) Localização específica

Fossa infratemporal, lateral ao n. mandibular, relaciona-se posteriormente ATM.

15 - Marcava a eminência articular, vertente medial.

a) O que define a inclinação da estrutura?

R.: Altura das cúspides, face incisal /oclusal dos elementos dentários anteriores e posteriores e morfologia dos dentes (dimensão vertical da boca em geral)

b) Músculos que agem para que haja deslizamento sobre a estrutura.

Mm. pterigóideos lateral e medial unilateralmente agindo no côndilo de trabalho para o lado oposto.

16 - Marcava o septo nasal. (Atenção: marcava o local onde havia a cartilagem do septo, mas estava com mucosa. Muita gente errou por ter achado que pedia a constituição da cartilagem, mas estava pedindo o septo como um todo.)

a) Constituição específica (quais partes de quais ossos, mucosa, etc).

Lâmina perpendicular do osso etmóide, osso vômer e cartilagem do septo nasal

b) Caso haja um desvio na estrutura, haverá alterações nas estruturas bucais? Explique sucintamente

R.: Com o desvio o indivíduo pode se tornar um respirador bucal, alterando assim as estruturas bucais, como palato, lábios e até os processos alveolares.

17 - Tinha 6 alfinetes marcando: Pedia pra citar APENAS a cor do alfinete e o nome das estruturas que, quando alteradas, poderiam diminuir a luz da passagem do ar pela cavidade nasal, dificultando a respiração (apenas as 3 últimas estruturas).

R.: Seio esfenoidal;

Seio frontal;

Seio maxilar; lembrar da abertura do seio maxilar (óstio do seio maxilar), no meato nasal médio; e no seio maxilar se chama “abertura para o meato nasal médio”

Concha nasal média;

Limiar do nariz;

Septo nasal.

18 - Marcava o terço anterior da língua.

a) Irrigação (lembrar de falar que o vaso irriga a hemilíngua)

R.: A. profunda da Língua, irrigando cada uma a hemilíngua de seu lado

b) Drenagem.

R.: Vv. Acompanhantes da A. profunda da língua e as vv. acompanhantes do N. Hipoglosso (XII)

19 - Um paciente foi ao CD para aplicar botox nas rugas da região (era a região lateral da órbita, "pés de galinha"). O paciente voltou ao consultório relatando que seu sorriso estava irregular. Explique o que pode ter acontecido utilizando seus conhecimentos anatômicos e quais músculos podem ter sido atingidos (zigomático maior e menor).

20 - 3 alfinetes marcando:

Nariz externo; A. dorsal do nariz, a. nasal lateral, ramos nasais da a. infraorbital, ramos nasais laterais

Lábio superior; a. labial superior, ramo labial superior da a. infraorbital

Região pouco acima do supercílio. a. supraorbital, a. supratroclear, r. frontal da a. temporal superficial

21 – Em um movimento de protrusão, que músculos atuam? Seja específico.

22 – Sobre a cavidade da boca, cite:

a) 3 estruturas intimamente relacionadas com a glândula parótida.

b) Limite medial do vestíbulo da boca.

23 – Sobre a parte profunda da glândula submandibular.

a) Defina-a.

b) Localize-a.

c) Cite uma relação anatômica anterior.

24 – Após receber uma pancada na cabeça, paciente apresentou um hematoma na tela subcutânea do túber frontal.

a) Explique anatomicamente como se comportará o hematoma ao longo dos dias.

b) cite as 3 principais artérias da região.

25 - marcava o pterigóideo lateral, perguntava se era palpado in vivo e ação unilateral

Não é palpável, agindo unilateralmente promove movimento de lateralidade

26 - marcava o ducto parotídeo, perguntava como palpar e o trajeto

Palpável ocluindo fortemente os dentes e apalpando o masseter.

tem início na parte superficial da glândula parótida. Continua superficialmente ao masseter até sua borda anterior. Perfura o corpo adiposo da face e o músculo

bucinador. Continua-se perfurando a mucosa oral e se abre na papila parotídea na altura do segundo molar superior.

27 - marcava o hioglosso e pedia ação
Promove depressão e retrusão da mandíbula

28- marcava a masseter fibras profundas e temporal fibras posteriores, pedia relação
Sinergistas no movimento de retrusão.

27- marcava a gland sublingual e pedia todas as relações anatômicas da região

28 - marcava tecido adiposo e pedia porque era importante saber
Importante saber pois se relaciona com o ducto parotídeo, artéria e veia facial transversa e em procedimentos de lipectomia pode-se romper essas estruturas.

29 - estratimeria da faringe
Mucosa, submucosa, fáscia faringobasilar, camada muscular, fáscia bucofaríngea

30 - feixes vasculonervosos do seio maxilar

31 - marcava o pterigóideo lateral e pedia ação bilateral e qual músculo ajudava nessa ação
Promove o abaixamento da mandíbula na abertura da boca. É auxiliado pelo ventre anterior do músculo digástrico.

32 - anastomoses da cavidade nasal
Artéria etmoidal anterior e posterior que são ramos da artéria oftálmica, que por sua vez é ramo da carótida interna, se anastomosam com ramos da artéria esfenopalatina, que é ramo da artéria maxilar, que é ramo da carótida externa.

33 - marcava a glândula submandibular e pedia relação anatômica principal
Se relaciona medialmente com o nervo lingual.

34 - Estratimeria do palato e como diferenciar palato duro de mole
Mucosa, submucosa, periosteo, osso, periósteo, submucosa nasal, mucosa nasal.
É possível diferenciar pela coloração visto que a mucosa do palato mole é mais escura devido sua composição muscular enquanto a mucosa do palato duro é rósea. E também é visível quando sons são emitidos.

35 - estratimeria do lábio
Pele, tela subcutânea, camada muscular, camada glandular (descontínua), submucosa oral e mucosa oral.

36 - marcava um espaço entre os constritores e passava o que passava ali

Base do crânio e constritor superior:

- artéria faríngea ascendente
- artéria palatina ascendente
- parte cartilaginosa da tuba auditiva
- músculo levantador do véu
- músculo tensor do véu

Superior e médio

- ligamento estilo hióideo
- músculo estilofaríngeo
- nervo glossofaríngeo

Médio e inferior

- artéria laríngea superior
- ramo interno do nervo laríngeo superior

Inferior e esôfago

- nervo laríngeo recorrente
- artéria tireóidea inferior

37 - marcava o óstio da tuba auditiva e importância em saber

Músculos levantador e tensor do véu palatino auxiliam na abertura do ostio em locais cuja pressão do ambiente é diferente da pressão interna, dando sensação de "entupimento". Também é importante saber que infecções vindas da cavidade nasal e parte nasal da faringe podem se disseminar para a orelha média através da tuba auditiva.

38- se uma pessoa levasse um soco na região do nariz, se podia afetar o cérebro e porque

Poderia afetar o cérebro pois poderia ter fraturado também a lâmina cribiforme do osso etmóide, que é recoberta por dura mater e aracnóide. Mater causando extravasamento de líquido.

39 - marcava o disco articular da ATM e pedia 3 características dele

Delgado no centro, composto por tecido fibroso, mais espesso na periferia, mais espesso na parte posterior, difícil regeneração, promove divisão da atm em dois compartimentos: supra e infra discal

40 - Parte superior da órbita (face orbital do osso frontal). Importância cirúrgica-clínica e 2 relações não-ósseas inferiores.

41 - A. carótida interna (pulsação). Explicar anatomicamente porque escutamos.

42 - 2 movimentos do músculo ECM.

43 - Trauma no ptério, consequência. (Hematoma extradural)

44 - 2 áreas de doação de enxerto da mandíbula.

45 - Como se dá a abertura do forame mentual.

46 - 2 anastomoses que suprem a. carótida comum.

47 - a) Processos da cavidade oral (palatino da maxila e lâmina horizontal do palatino) que formam o palato?

b) Identificar a sutura na linha mediana (palatina mediana) e dizer o que proporciona (crescimento laterolateral).

48 - Lâmina perpendicular do osso palatino (que osso pertence, o que ele delimita e qual o forame superior).

49 - Identificar e dizer a importância clínica para a odontologia do nervo auricular magno.

50 - Identificar todos os tipos de linfonodos do colar pericervical - peça: bebê

51 - Ramos da a. maxilar e acidentes ósseos correspondentes (a. alveolar superior posterior, a. infraorbital).

52 - Relação da v. jugular externa com ECM e pra qual vaso ela irá drenar, normalmente.

53 - Nervos que estão na parede lateral do seio cavernoso e dois vasos que drenam diretamente para o seio.

54 - Importância e função do seio carótico.

55 - a)Tubérculo faríngeo: uma relação anterior e uma posterior

b)Protuberância occipital interna, duas estruturas que se associam.

56 - ATM: quais acidentes ossos o formam? (fossa mandibular, eminência articular e cabeça da mandíbula).

57 - Ramo occipital da a. carótida externa e pedia duas relações não-óssea.

58 - Delimitação do espaço retrofaríngeo e sua importância.

59 - Qual relação que os músculos apontados apresentam entre si:

Masseter e Ventre anterior do digástrico

R: São antagonistas. Masseter eleva mandíbula

Ventre Anterior do Digástrico abaixa a mandíbula

60 - Sobre a ação dos músculos apontados, cite o que eles têm em comum.
Pterigóideo lateral e medial

R: São sinergistas nas protrusão e lateralidade

61 - Cite os nome dos ligamentos da atm e grife o mais potente

R: Ligamento esfenomandibular, estilomandibular e temporomandibular

62 -Cite 3 relações anatômicas da estrutura apontada:

ducto da glândula parótida

R: masseter, bucinador e corpo adiposo da face

63 - a)Sobre o movimento de protrusão da mandíbula responda. Quais faces articulares se tocam?

R: Vertente lateral da vertente posterior da eminência articular com a vertente lateral da vertente anterior da cabeça da mandíbula

b)Quais são as faces dentais que se tocam?

R: Face vestibular dos incisivos inferiores deslizam sobre a face lingual dos incisivos superiores

64 - Sobre a estrutura apontada responda. Músculo hióide.

a) No paciente, o que podemos utilizar como referência para saber onde está sua margem posterior?

R: face distal do terceiro molar

b)Cite 3 estruturas que se relacionam intimamente com sua face superior.

parte profunda da glândula submandibular, sublingual, nervo lingual e ducto da glândula submandibular

65 - Cite ações do músculo apontado, seja específico. Pterigóideo medial

R: bilateralmente - protrusão e elevação

unilateralmente - lateralidade para o músculo oposto ao que está contraindo

64 - Principais ações dos músculos.

hioglosso- abaixa e retrui

genioglosso- abaixa e protraí

palatoglosso- levanta a língua abaixa o palato

65 - a) Identificar a estrutura

lábio medial ou parte profunda da glândula parótida

b) Relação medial(órgão)

faringe

c) Dentro da estrutura apontada tem fibras do nervo facial?

não

66 -Quais as camadas da região apontada (região temporal)? De mais profundo pra superficial, grife a primeira camada que tem continuidade com a fossa infratemporal.

R: pele, tela subcutânea, aponeurose/fáscia temporoparietal, tecido subaponeurótico frouxo, fáscia temporal, músculo temporal, pericrânio, crânio.

67 - Identifique na estrutura apontada:

localização: transição do teto com a parede posterior da parte nasal da faringe

Outras estruturas histológicas: tonsila palatina, tubária e lingual

QUESTÕES P3 - NEUROANATOMIA

1 - Órbita. (Marcava o nervo lacrimal antes de receber o ramo comunicante com o nervo zigomático).

a) Relações anatômicas laterais.

M. reto lateral,

b) Classificação funcional no local apontado. Justifique.

ASG

2 - Marcava o n. facial no canal do facial.

a) Estrutura que têm íntima relação com esse nervo na orelha interna.

R.: M. Estapédio

b) Núcleos.

R.: Núcleo motor do N. Facial e Núcleo Salivatório Superior e Núcleo do Trato Solitário

3 - Paralisia de nervo facial.

a) Dois locais mais comuns de se observar a paralisia.

R.: Região da boca (m. orbicular da boca) e Região do Olho (m. orbicular do olho)

b) Motivo pelo qual o terço superior da hemiface do paciente não apresentou paralisia.

6 - Apontava o n. Glossofaríngeo.

a) Qual músculo tem íntima relação com esse nervo e é innervado por ele?

R.: músculo estilofaríngeo

b) Cite um núcleo sensitivo e um núcleo motor para os quais são enviadas as informações.

R.: Motor: Núcleo Ambíguo

Sensitivo: Núcleo do Trato Solitário

c) Por qual forame ele emerge do crânio?

Forame jugular.

7 - Apontava o n. Palatino maior.

a) Origem e trajeto ósseo de sua origem ao seu término.

R.: G. Ptpl na Fossa ptpl, desce pelo canal palatino e emerge pelo forame palatino maior na região palatina (palato duro), em direção à gengiva ling. dos dentes superiores (até Canino)

b) Classificação funcional.

R.: ASG

8 - Marcava o gânglio cervical superior.

Cite 5 locais para onde serão direcionadas as fibras simpáticas no crânio.

R.: Gl. Lacrimal, Conchas Nais, Palato, Bulbo Ocular e Glândulas Submandib e Sublingual

9 - Marcava o n. mandibular. Relações anatômicas e classificação funcional.
Relaciona-se lateralmente com o m. pterigóideo lateral, posteriormente com a. meníngea média, medialmente com o m. tensor do véu palatino.
ASG/EVE

10 - Marcava o n. hipoglosso.
Relações anatômicas no assoalho da boca e o que acontece em caso de lesão.
R.: Ducto da Gl. Submandibular e n. lingual (superiormente), Vv. acompanhantes do N. Hipoglosso, m. milo-hióideo (superficial - lateral), m. hioglosso (profundo - medial)

11 - Marcava o n. Bucal.
3 relações anatômicas no início de seu trajeto e território de inervação.
- Inferior à cabeça sup do m. pt. lateral,
- Sup. à cabeça inf. do m. pt. lateral,
- Anterior aos Nn. Lingual e Alv. Inf.

12 – Marcava o NASA.
3 tipos diferentes de estruturas que ele recolhe sensibilidade.
Gengiva e mucosa vestibular, dentes anteriores e parte da pele do lábio superior e da asa do nariz.

13 - Classifique funcionalmente as fibras nervosas das raízes dos nervos espinais.

14 - Cite 5 diferenças entre AS e AV.

15 - Qual é a função do sistema límbico? Qual é a sua relação com as memórias?

16 - O que é e qual é a função do sulco limitante?

17 - Cite os 4 gânglios parassimpáticos e a região que estão localizados?

18 - a) Classificação do triângulo do hipoglosso? ESG
b) Porquê dessa classificação?

19 - Função do hipotálamo?

20 - Relação anatômica importante do nervo auriculotemporal? Era artéria meníngea média, ATM e glândula parótida.

21 - a) Nervo nasopalatino na região de cav. Nasal e perguntava classificação funcional ? ASG e EVG
b) De onde saía o nervo e onde estava?

22 - Origem aparente do nervo facial no encéfalo e no crânio? Que era sulco bulbo ponto no e forame estilomastóideo.

23 - a)apontava para o sulco pré Central e perguntava o que era?
b) Classificação funcional da área?

24 - a) apontava o nervo vago e dava 2 classificações funcionais e perguntava o que inervava em relação àquela classificação?

25 - Apontava para o nervo acessório e perguntava sua formação e estruturas que inervava?

26 - a)Apontava para o colículo do facial e perguntava o conteúdo? Que era o núcleo do abducente envolto pelo facial!
b)Perguntava tbm em relação ao colículo facial caso tivesse uma lesão quais seriam as consequências?

27 - Apontava para o arco superciliar (parece que era em relação ao nervo infra-orbital) e perguntava relações mediais ósseas!

28 - Apontava para a maçã do rosto e perguntava caso tivesse lesão qual seria o sintoma em relação ao nervo ali presente?

29 - Apontava para o joelho do facial e perguntava o que era? E qual ramo saía dele? Que era o n. Petroso maior.

30 -Apontava para o nervo alveolar inferior e perguntava uma relação anatômica medial e lateral? E perguntava tbm onde terminava? A resposta era mais ou menos ramos incisivos...

31 - Apontava também para alguns nervos e pedia para colocar a cor do alfinete e o nome dos nervos ali presentes que tinham fibras parassimpáticas

32 - Perguntava do cerebelo qual parte é responsável pelo planejamento e pela correção? Parte lateral e Central.

33 - Apontava para o nervo hipoglosso e pedia 3 relações anatômicas nervosas ou musculares?

34 - Perguntava sobre o nervo maxilar uma intervenção nesse nervo para citar 2 fatores que apontavam que a intervenção seria certa.

35 - MARCAVA O TRÍGONO DO HIPOGLOSSO E PEDIA COMPOSIÇÃO

36 - MARCAVA O ABDUCENTE E PEDIA TRAJETO

37 - MARCAVA O PETROSO MAIOR E PEDIA CLASSIFICAÇÃO
ASG, EVG (parassimpática), AVE

38 - MARCAVA OS NÚCLEOS DA BASE E IDENTIFICAÇÃO

39 - MARCAVA O GIRO PRÉ CENTRAL E PERGUNTAVA SE LESIONAR O LOCAL
O QUE ACONTECIA

40 - NERVO LINGUAL E ALVEOLAR INFERIOR: RELAÇÕES ANATÔMICAS
MEDIAIS E LATERAIS QUANDO PASSAM PELO COLO DO CÔNDILO E
CLASSIFICAÇÃO

41 - RAMOS DO INFRAORBITAL E CLASSIFICAÇÃO
Alveolar superior médio (asg) e anterior (asg), ramos palpebrais inferiores (asg),
ramo nasal lateral (asg) e nervo labial superior (asg)

42 - PEDIA TRAJETO DAS FIBRAS PARASSIMPÁTICAS ATÉ A PARÓTIDA

43 - MARCAVA NERVO LINGUAL E PEDIA TODAS AS RELAÇÕES ANATÔMICAS
NA CAVIDADE ORAL

44 - GÂNGLIOS PARASSIMPÁTICOS E QUAIS NERVOS ESTÃO
RELACIONADOS

Ciliar - oculomotor

Pterigopalatino - facial

Submandibular - facial

Ótico - glossofaríngeo

45 - GÂNGLIO CERVICAL SUPERIOR. TIPOS DE FIBRAS E FUNÇÃO

Simpáticas evg

Inervação simpática da glândula submandibular e sublingual e de vasos ao redor da
glândula parótida

46 - DESCREVER A INERVAÇÃO DA LÍNGUA

47 - A) Diferenças encontradas nos níveis da medula

B) Motivo da existência da estrutura apontada (intumescência cervical).

48 - N. Hipoglosso

a) Fibras funcionais próprias vão inervar o que?

b) Lesão unilateral, sinal clínico.

49 -Corda do tímpano

a)O que inerva?

b)Origem real das fibras sensitivas.

50 - Córtex e substância branca no telencéfalo, definir.

51 - N. Palatino maior e n. alveolar posterior(seio maxilar), o que inervam?

52 -I CS e 1PMS (identificar), quais nervos anestésiar para extração?

53 - Giro pré-central e sulco calcarino, identificar e função.

54 -Gânglios parassimpáticos da cabeça e nervos relacionados.

55 - 3 diferenças da lesão central e periférica do nervo facial.

56 - Gânglio cervical superior, o que representava e classificação funcional.

57 - N. Vago, na lesão qual o sinal clínico na cavidade própria da boca e quais ramos estão relacionados.

58 - N. lingual lesão perto da língua quais estímulos o profissional irá relatar e quais outras estruturas serão afetadas.

59 - Fascículo cuneiforme - Dois estímulos e de onde vem esses estímulos.

60 - N. Auriculotemporal. Duas relações anatômicas e a importância do dentista saber essas relações.

61 - Quais tecidos alvos dos estímulos: ASG; EVG; EVE.

62 - Fratura do osso zigomático, qual importância para os nervos da órbita? Principal relação anatômica dessa estrutura nervosa?

63 - Alfinete na oliva e no triângulo do vago, constituição específica de cada um.

64 - Alfinete na pele da fronte. O que vai anestésiar? Principal relação do nervo anestesiado.

65 - Gânglio pterigopalatino a)Nome

b)Localização

c)Todas as fibras que passam

66 - Alfinete na linha mediana do lábio inferior. Qual nervo deve-se anestésias para remover uma lesão nessa área? Onde e como deve-se realizá-la?

QUESTÕES P4 - TOPOGRAFIA

1- Região nasal.

a) Estratimeria (especifique).

Na parte superior: pele, tela subcutânea, plano muscular e ossos nasais.

Na parte inferior: pele, tela subcutânea, cartilagens alares maiores e menores, projeções dorsais da cartilagem do septo nasal.

b) Irrigação.

- A. dorsal do nariz (ramo da a. oftálmica, que é ramo da ACl);
- Ramo do septo nasal e ramo nasal lateral (da a. facial);
- Ramo nasal (ramo da a. infraorbital).

2 - Região oral.

a) Localização estratigráfica dos vasos:

Entre a camada muscular e a submucosa.

b) Irrigação.

- a. labial superior e inferior (da a. facial);
- ramos terminais da a. bucal;
- a. mentual (ramo da a. alveolar inf.);
- ramo labial superior da a. infraorbital.

3 - Região mentual.

a) Drenagem linfática (especifique).

Submandibulares lateralmente e submentuais medialmente.

b) Características da tela subcutânea da região.

O tecido adiposo não forma uma camada contínua, dando o aspecto rugoso ao mento quando o músculo mentual é contraído, além de também possuir fibras do m. platisma.

4 - Marcava o lábio inferior.

a) Como anestésiar a região?

Anestesia do forame mentual bilateralmente, posicionando a agulha de posterior para anterior, de lateral para medial e superior para inferior.

b) Em quais camadas posso atuar após a anestesia na região do mento (seja específico).

Pele do mento e do lábio inferior, mucosa do lábio inferior

5 - Marcava o n. Bucal

a) Regiões que ele transita.

Infratemporal, parotídeomassetérica, bochecha e gengivodental

b) Relações anatômicas principais na região da bochecha.

Superficial ao m. bucinador, perfurando-o, chegando a mucosa da bochecha e innervando-a;

Passa inferior ao ducto da gl. parótida antes de perfurar o m. bucinador.

6 - Marcava o n. Palatino maior

a) Regiões que ele transita.

Região pterigopalatina, palatina e gengivodental.

b) Território de inervação (seja específico).

Mucosa e periósteo do palato, gengiva palatina dos dentes superiores posteriores e glândulas salivares do palato.

7 - Marcava o n. auriculotemporal.

a) Regiões que ele transita.

Infratemporal, parotidomassetérica, auricular e temporal.

b) 2 relações anatômicas principais na fossa infratemporal.

Artéria meníngea média com a abotoadura e músculo pterigóideo lateral (superficial a cabeça superior do músculo).

8 - a) Onde estão localizados os 3 gânglios parassimpáticos estudados?

Gânglio Ótico - região infratemporal

Gânglio Pterigopalatino - região pterigopalatina

Gânglio Submandibular - região sublingual

b) Cite 1 local para onde vão as fibras de cada gânglio.

G. ptpal.: septo nasal

G. submandibular: glândula submandibular

G. ótico: gl. Parótida.

9 - Marcava a tonsila palatina.

a) Relação anatômica lateral

m. constritor superior da faringe

b) Essa relação separa essa estrutura de qual região?

Região infratemporal.

10 - Marcava o n. auriculotemporal (lembrar que ele é sensitivo e motor).

Território de inervação (seja específico).

Glândula parótida, ATM, pele anterior da têmpora

11 - Marcava a eminência articular

a) Qual é a vertente fisiológica?

Posterior

b) Nome do ângulo entre a vertente medial e lateral.

Ângulo de Bennet

c) Movimento realizado na vertente medial. (lateralidade para o lado oposto).

Lateralidade para o lado oposto ao m. contraído no côndilo de trabalho e pequena rotação no côndilo de não trabalho.

12 - Pedia pra descrever o território de inervação de algumas estruturas

- a) n. mentual - **Pele e mucosa do lábio inferior, gengiva vestibular de incisivo até 1PMI**
- b) NASA - **Mucosa da parte anterior da parede anterolateral do seio maxilar, ICS, ILS, CS e sua mucosa vestibular, periodonto e periósteo, além da pele da asa do nariz e pele e mucosa do lábio superior.**
- c) n. palatino maior - **inerva gengiva palatina de 1PMS, 2PMS, 1MS, 2MS e 3MS, o palato ósseo e as glândulas do palato.**
- d) n. alveolar inferior - **3MI, 2MI, 1MI e 2PMI, periodonto e seus tecidos de suporte**
- e) n. bucal - **pele e mucosa da região da bochecha e a gengiva vestibular de 2PMI até 3MI.**

13 - Marcava a parte anterior do palato.

a) Caso de paciente que precisava fazer uma biópsia na mucosa da região. Qual nervo anestésiar? **(N. Nasopalatino).**

b) Paciente apresentou necrose. Motivo? Explique anatomicamente.

a solução anestésica foi depositada no vaso

14 - Marcava a fáscia temporiparietal.

3 motivos pelos quais ela pode ser utilizada como área doadora de enxerto.

- **natureza fibrosa**
- **bastante vascularizada**
- **grande área de doação**

15 - SMAS. O que você entende por esse termo? Qual é sua importância?

Sistema Músculo Aponeurótico Superficial - formado pelas fáscias temporoparietal, masseterica e parotídea. Importante para manter a cútis com aspecto jovem tencionando-a para posterior.

16 - Paciente com sialolitíase. Precisava fazer uma incisão para acessar o ducto da glândula submandibular.

a) Região da incisão.

Sublingual

b) 3 estruturas vasculonervosas que podem ser lesadas.

A. lingual, v. lingual, n. lingual, n. hipoglosso.

17 - Marcava o n. Infraorbital.

a) Onde começa, onde termina e regiões que ele transita.

fissura orbital inferior e forame infraorbital.

Região infraorbital e zigomática, região pterigopalatina*.**

b) Cite 3 ramos desse nervo.

n. alveolar superior médio

n. alveolar superior anterior

ramos labiais superiores

ramos palpebrais inferiores
ramos nasais.

18 - Marque a região submandibular.

a) Como deve ser a posição do paciente para inspecionar a região?

Cabeça levemente fletida (abaixada) para relaxar os músculos da região e facilitar a palpação das estruturas.

b) Linfonodos que podem ser palpados.

Submandibulares, submentuais, cervicais superficiais e cervicais laterais profundos superiores.

19 - Marque o ducto da glândula parótida.

a) Cite dois tipos de procedimentos nos quais o CD pode lesar a estrutura.

Bicectomia, Preenchimento.

b) Cite duas formas de preservar as lesões da estrutura.

Pedir ao paciente para ocluir, contraindo o m. masseter fortemente para palpar o ducto parotídeo e também traçar uma linha imaginária do tragus até o ângulo da boca e em seu terço médio estará o ducto.

20 - Questão tinha a foto da apostila de afundamento/fratura de zigomático.

a) Diagnóstico

Fratura do osso zigomático

b) Causas.

Quedas, acidentes automobilísticos e agressões físicas

c) Cite 6 sinais ou sintomas.

Edema, dor, parestesia, hematomas, diplopia, deslocamento ocular e afundamento da maçã do rosto.

21 - Sobre a região parotidomassetérica.

a) Limites.

Superior: margem inferior do osso zigomático

Anterior: margem anterior do m. masseter

Posterior: margem posterior do ramo da mandíbula

Inferior: margem inferior da mandíbula (entre o limite anterior e posterior)

Medial: face lateral do ramo da mandíbula

b) Origem e ação do principal músculo da região (seja específico).

m. masseter.

origem: a parte superficial na margem inferior dos $\frac{2}{3}$ anteriores do arco zigomático;
a parte profunda na margem inferior do $\frac{1}{3}$ posterior do arco zigomático.

inserção: face lateral do ramo da mandíbula (tuberosidade massetérica)

22 - Sobre a região oral:

a) Irrigação.

a. labial superior e inferior (a. maxilar)

ramo labial superior (a. infraorbital)

ramos terminais da a. bucal

ramo mental (alveolar inf.)

b) Inervação.

motor: ramos bucais do n. facial

sensitivo: ramos labiais superiores (n. infraorbital) e ramos labiais inferiores (n. mental)

23 - Sobre a região da bochecha:

a) Diferenças de estratigrafia.

$\frac{2}{3}$ superiores: pele, tela subcutânea (mais espessa), camada muscular, camada submucosa (mais escassa) e mucosa; $\frac{1}{3}$ inferior: pele, tela subcutânea, camada muscular e camada óssea)

b) Desenhe um esquema com o trajeto das artérias e cite quais são.

a. mental

a. facial transversa (ramo da temporal superficial)

a. bucal

a. facial

24 - a) A região infratemporal permite exame físico? Se sim, onde?

A região é de difícil exploração clínica. Pode ser parcialmente inspecionada pela cavidade própria da boca, em um pequeno intervalo entre o ramo da mandíbula e faringe.

b) Drenagem linfática

Drenam para os linfonodos cervicais laterais profundos superiores e inferiores (cadeia jugular)

25 - a) Comunicações anterior e superior da fossa ptpl (uma de cada).

Anterior: órbita através da fissura orbital inferior

Superior: fossa média do crânio através do canal pterigóideo e forame redondo

b) Relações anatômicas do gânglio pterigopalatino. (Ele queria os limites da fossa ptpl como relação).

Anterior: face posterior da maxila

Posterior: face anterior do processo pterigoideo

Medial: face lateral (maxilar) da lâmina perpendicular do osso palatino

Lateral: porta virtual (fissura pterigomaxilar)

Superior: asa maior do esfenóide

26 - a) Relações anatômicas do corpo da glândula submandibular.

Face Medial: m. digástrico, m. estilo-hióideo, m. milo-hióideo e hioglosso.

Face Lateral: metade superior se relaciona com a fôvea submandibular e a inferior com a lâmina superficial da fáscia cervical

b) Localização da parte profunda da glândula submandibular (seja específico).

região sublingual, entre os músculos milo-hióideo (lateralmente) e hioglosso e genioglosso (medialmente); superiormente com o n. lingual e inferiormente com o n. hipoglosso.

27 - Cite os nervos e o território de inervação da região gengivodental na mandíbula.

n. bucal - molares

n. mentual - pré molares e incisivos

n. incisivo - caninos e incisivos

28-Alfinete na região mentual:

a)Irrigação

a. mentual, a. submentual e a. labial inferior

b)Inervação sensitiva

n. mentual

29-Alfinete na região da bochecha

tela subcutânea é contínua com que regiões? Explique sucintamente.

temporal e infratemooral, constituindo um veículo fácil de propagação de infecções

30-Alfinete na região da bochecha

Como deve ser realizada a extração de lesões nessa área e qual o motivo?

pela intervenção direta através da superfície afetada (?????)

31-Alfinete na região sublingual

a)Limite posterior(especificar)

se comunica livremente com a região submandibular

b)Importância (explique)

facilita a difusão cervical dos processos patológicos de origem bucal

32-Alfinete na região sublingual

a)Irrigação principal

a. lingual

b)Qual o principal vaso que drena essa região?

v. jugular interna

33-Alfinete no processo profundo da glândula submandibular. a)Identificar

b)Em uma incisão inadvertida, cite dois nervos que podem ser lesados?

n. lingual e n. hipoglosso

34-Alfinete na região submandibular

a)Camadas atravessadas em uma incisão da região.

pele, tela subcutânea, m. platisma e lâmina superficial da fáscia cervical

b)Como devem ser realizadas? Explique.

seguindo as linhas de tensão natural da pele para melhor cicatrização

35-Alfinete no palato mole e na tonsila palatina. Pedia o que elas tinham em comum em relação à:

a)Irrigação

a. palatina menor

b)Drenagem linfática

drenam para os linfonodos cervicais laterais profundos superiores (??????)

36-Identificar os mm. pterigóideos lateral e medial e dizer suas ações.

medial - elevação, protrusão e lateralidade

lateral - abertura, protrusão e lateralidade

37-Alfinete no nervo lingual (e diz o Ricardo que tava no alveolar inferior tbm)

a)Nome

b)Local de bloqueio (anestesia)

n. lingual - gengiva lingual e $\frac{2}{3}$ anteriores da língua

n. alveolar inferior - polpa, ligamento periodontal e processo alveolar do terceiro molar inferior até o primeiro molar inferior

c)Todos os ramos

n. lingual - n. sublingual

n. alveolar inferior - n. mentual

38-Alfinete na artéria alveolar superior posterior e na artéria esfenopalatina. Identificar e dizer o que irrigava.

a.alveolar superior posterior - polpa, ligamento periodontal e periósteo dos molares superiores

a. esfeno palatina -

39-Alfinete na região infraorbital

A)Nome da região

B)Anestésico nessa região vai inervar que estruturas importantes pro dentista?

40-Completar o texto igual o da apostila com os músculos que atuam no desnível da mandíbula quando há uma fratura.

41-Região temporal. Nervos motores e em que camada se encontram.

42-Importância clínica da relação topográfica da glândula parótida com os ramos do nervo facial.

43-A)Principal nervo sensitivo da região sublingual e fibras que ele contém. B)Qual a importância da região, levando em consideração os dentes inferiores?

44-Drenagem linfática da região nasal.

45-Alfinete em um tecido adiposo. A)Nome
B)É contínuo com que regiões?

46-Alfinete no gânglio pterigopalatino

A)De onde vêm as fibras pré-sinápticas para esse gânglio? B)Duas estruturas inervadas pelas fibras pós-sinápticas

47-Alfinete em algumas regiões e pedia inervação.

1)Molar superior: N. alveolar superior posterior.

2)Mucosa lingual no nível dos molares: N. palatino maior.

3)Mucosa lingual no nível dos incisivos: N. nasopalatino.

4)Gengiva vestibular no nível dos incisivos: N. alveolar superior anterior.

5)Lábio superior: N. alveolar superior anterior e n. labial superior.

QUESTÕES DE PROVA FINAL

- 1 - Forame supra-orbital apontado: perguntava a estrutura específica superficial, que era o músculo corrugador do supercílio.
- 2 - Nervo corda do tímpano apontado: relações e localização
- 3 - M. pterigóideo medial e lateral, relação entre eles
- 4 - N. Alveolar superior e n. Palatino maior: dizer tudo que eles nervavam
- 5 - Trajeto da a. Facial até a órbita
- 6 - Estratimeria da região temporal e do pescoço até a laringe
- 7 - N. Parassimpático, núcleo dele e gânglio: n.petroso maior
- 8 - Acidentes não musculares da mandíbula (glândulas e dentes)
- 9 - Região orofaringe: inervação sensitiva da região
- 10 - Região sublingual: relação medial e inervação
- 11 - Extração do 46: qual a. Lesionaria no colo da mandíbula
- 12 - Extração de ICS e MS: quais nervos bloquear
- 13 - Região que está localizado os músculos masseter e temporal, e inervação deles
- 14 - Dorso da língua: falar das principais diferenças
(ausência de papilas gustativas ou não e inervação de 1/3 e 2/3 da língua)
- 15 - Vestíbulo da boca apontado: pedia o nome, inervação e explicar
- 16 - Cavidade nasal: identificar bolha etmoidal, óstio do seio maxilar
- 17 - Identificar mm. pterigóideo lateral.
a) Ação.
b) 2 principais relações.
- 18 - a) Seta na vertente lateral da eminência articular - Movimentos.
b) Seta na fossa mandibular - Importância de saber os limites medial e lateral.
- 19 - Vestíbulo da boca

- a) Limites anteriores e mediais
- b) Aberturas e comunicações

20 - Limite posterior do milo hióide - Importância e referência clínica.

21 - Região sublingual

- a) Principal irrigação e inervação
- b) Relação medial.

22 - Alfinete no nervo lingual (Peça que mostra ele cruzando o ducto da glândula submandibular.

- a) Onde anestesia?
- b) O que anestesia?

23 - Alfinete no n. auriculotemporal.

- a) Duas relações principais do nervo.
- b) Ele se encontra em quais regiões topográficas?

24 - a) N palatino maior, função.

- b) N alveolar superior anterior, função.

25 - M. bucinador e m. orbicular da boca: principal ação e ramos que inervam.

26 - Alfinetes que indicavam rugas dinâmicas causadas pelos mm. occipitofrontal (ventre frontal), m. corrugador do supercílio e m. orbicular dos olhos. Tratamento indicado e dizer quais mm.

27 - A diferença da compactação óssea da maxila e da mandíbula, o que afeta:

- a) Nas anestésias
- b) Na reabsorção óssea.

28 - 2 vias do triângulo perigoso da face. Trombose do seio cavernoso.

29 - Nn. que deverão ser anestesiados na extração do canino superior e do primeiro molar superior.

30 - Um vaso ou um nervo relacionado com:

- A) Forame incisivo
- B) Forame mental
- C) Margem inferior da mandíbula
- D) Forames alveolares
- E) Colo da mandíbula

31 - Seta na região do ptério.

- A)Qual artéria tem relação profunda com a região apontada.
- B)Qual a consequência de um trauma na região?

32 - Seta na impressão trigeminal

- A)Estrutura nervosa presente
- B)Relação vascular

33 - Delimitação e importância clínica do espaço retrofaríngeo.

34 - Alfinete na a. carótida externa - 3 anastomoses que suprem a obstrução dessa artéria.

35 - 3 acidentes ósseos que deverão ser preservados no acesso anterior do seio maxilar.

36 - Paciente fez cirurgia na cavidade timpânica e perdeu a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua.

- A)Qual estrutura nervosa pode ter sido lesionada?
- B)Quais as outras consequências dessa lesão? Especifique as estruturas.

37 - Hipotrofia dos mm. da hemilíngua.

- a)Qual nervo lesionado?
- b)Qual o exame clínico?

38 - forames parietais e sua importância

39 - em qual região ocorre a confluência dos seios

40 - estratigrafia da região temporal e em qual camada a a. temporal superficial se localiza

41 - 4 diferenças entre uma mandíbula desdentada e uma normal

(desdentada: forame mental mais próximo do rebordo residual, processo coronóide mais pontiagudo, ângulo da mandíbula mais obtuso, espinhas genianas mais desenvolvidas)

42 - qual nervo deverá ser bloqueado na anestesia de: palato mole, mucosa vestibular nos dentes anteriores, mucosa vestibular dos posteriores.

43 - limites anterior e lateral do vestíbulo oral

44 - apontava no bucinador num corte transversal e pedia o nome e acho que inervação e vascularização

45 - anestesia na pele do mento: onde anestésia e referência para a anestesia

46 - a) Sinergismo entre mm. Da mastigação (exemplo: dê 2 sinergistas do m. apontado: aponta na parte superficial do m. masseter, que faz protrusão e elevação da mandíbula, e vc fala como sinergista o m. pterigóideo medial, que faz os mesmos movimentos e a parte superior do m. pterigóideo lateral, que faz protrusão)
b) uma relação anatômica medial (principal) do masseter.

47 - (atm) quais movimentos o côndilo fazia e uma relação anatômica posterior.

48 - onde se localiza o linfonodo jugulodigástrico

DICAS BÔNUS

Para estudar para a prova final, não se estuda separado. Sempre atentar para um estudo geral em conjunto. Ex.: Estudar osso da mandíbula, saber quais mm se inserem, qual sua vascularização e inervação. Seguem alguns tópicos que podem cair na prova, isso são coisas que já caíram em provas passadas.

- Estudar as relações anatômicas do seio esfenoidal, maxilar
- Saber os ossos que compõe a órbita
- Saber que o seio frontal tem um ducto que drena para o meato médio
- Saber as delimitações da fossa infratemporal e conteúdo.
- Saber algumas aberturas da fossa pterigopalatina e também conteúdo. (vasos e nervos que contém)
- Músculos da mímica, estudar localização de cada
- Músculos da mastigação (muito importante saber origem e inserção)
- Saber a estratigrafia do palato duro e mole
- Músculos intrínsecos e extrínsecos da língua (rogerio às vezes pedia quando era ele que dava essa matéria)
- Anestesia de dentes , anestesia de palato e língua (cuidado para não confundirem alguns casos que é hemilateral)
- Relação anatômica do nervo lingual em relação na cavidade oral (tem relação com ducto da glândula submandibular)
- Relação anatômica das glândulas sublinguais, submandibular (saber do corpo e parte profunda) e também da parótida
- Trígonos submandibular e submental sempre caem (estudar limite, conteúdo, tudo sobre eles)
- Na glândula parótida tem conteúdo, é necessário saber (contém nervo, veia e artéria, saber quais e qual a ordem de dentro para fora)- Muito importante
- Saber a estratigrafia do couro cabeludo (scalp)
- Anel linfático (tonsila palatina, faríngea e lingual)
- Ramos terminais da artéria carótida externa (saber visualizar na peça)
- Importante saber no geral as artérias e veias
- Na região do ptério, lembrar se acontecer um trauma, o que pode ocasionar? Tem vasos importantes passando profundamente nessa região? Lembrar da artéria meníngea média (no atlas do netter tem explicando isso e mostra até figuras)
- Lembrar que o tipo de neurônio bipolar é encontrado na retina
- Alça do nervo hipoglosso
- Quais fibras o nervo trigêmeo carrega
- O prof sempre pergunta, tal nervo é ASG, AVG ... ?
- Na fossa pterigopalatina, lembrar os nervos que saem deste local
- Saber para qual espaço uma infecção em tal dente drena
- Importância do trígono perigoso da face

- Retirada de tórus palatino, quais nervos bloquear e quais camadas iriam ser atingidas (importante se atentar na localização desse tórus para saber se terá glândulas ou não)
- Comunicação entre fossas
- Nervo infraorbital muito importante, saber seu trajeto
- Aquele negócio de sulco, canal e forame infraorbital (caiu uma vez na prova final) TODO MUNDO ERROU QUANDO CAIU ESSA QUESTÃO NA FINAL, NERVO INFRA-ORBITAL SÓ É CHAMADO DE INFRA-ORBITAL QUANDO PENETRA NA FISSURA ORBITAL INFERIOR E VAI PRA CAVIDADE ORBITÁRIA. ATENÇÃO A ISSO, SE COLOCAR ANTES DE ENTRAR NA FISSURA ORBITAL INF. É NERVO MAXILAR.

Isso é apenas um guia do que já caiu em provas passadas, não sei se é exatamente isso que cairá.

Não se preocupem com a prova, ir tranquilo é meio caminho andado. Se der, deu. Se não, tem outras oportunidades. Nem tudo é como a gente quer.

Abraços e boa prova a todos.